

Cáncer de cavidad oral, nasofaringe y laringe

1. Introducción y relevancia clínica

Los **cánceres de cabeza y cuello** representan alrededor del **5% de todos los cánceres** en adultos y constituyen una de las neoplasias más relevantes en otorrinolaringología.

Dentro de ellos, los de **cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, nasofaringe y laringe** son los más frecuentes.

En Chile, el **carcinoma epidermoide (escamoso)** es el tipo histológico predominante (>90%), asociado fuertemente al **tabaquismo y al consumo de alcohol**, aunque en los últimos años se ha observado un aumento de casos **asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH, subtipos 16 y 18)**, especialmente en **orofaringe**.

El pronóstico depende de la **detección temprana**, ya que los síntomas iniciales suelen ser **inespecíficos y fácilmente pasados por alto en APS: disfonía persistente, úlceras orales que no cicatrizan o disfagia progresiva**.

Su **diagnóstico precoz** mejora radicalmente la sobrevida (hasta 80–90% en estadios iniciales).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Tipo histológico predominante

- **Carcinoma escamoso**: se origina en el epitelio escamoso de las mucosas del tracto aerodigestivo superior.
- Menos frecuentes: **adenocarcinoma** (glándulas salivales menores), **linfoma**, **melanoma mucoso**, **sarcomas**.

2.2 Factores de riesgo

Categoría	Ejemplos
Tabaquismo (principal)	Riesgo relativo 10–20x; relacionado con cavidad oral y laringe.

Alcohol	Efecto sinérgico con tabaco; potencia mutagénesis epitelial.
Infección por VPH (16,18)	Especialmente en orofaringe (amígdalas, base de lengua). Mejora pronóstico.
Exposición laboral	Asbesto, polvo de madera, formaldehído, metales pesados.
Factores genéticos	Síndromes raros (Fanconi, Bloom).
Mal estado dental / prótesis irritantes	Inflamación crónica y traumatismos locales.
Nutrición deficiente	Bajo consumo de frutas/verduras, déficit de vitamina A.
Radiación previa	En cabeza y cuello.

2.3 Fisiopatología molecular

- Mutaciones en **TP53, CDKN2A, EGFR, RAS, PI3KCA**.
 - En cánceres **VPH positivos**, el **ADN viral** integra genes **E6/E7** → inactivación de **p53 y Rb**, respectivamente.
 - Resultado: **pérdida de control del ciclo celular**, proliferación anómala, **angiogénesis** y **evasión inmunitaria**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Cáncer de cavidad oral

Localizaciones: mucosa yugal, piso de boca, lengua, encía, labio inferior, paladar duro.

Síntomas iniciales:

- **Úlcera o placa blanca/roja persistente** (>2–3 semanas).
- Dolor local o irradiado a oído.
- **Disartria, disfagia leve**, sangrado o halitosis.
- **Movilidad dentaria sin causa aparente.**

Hallazgos físicos:

- Úlcera indurada con bordes elevados y base infiltrada.
- Masa exofítica o leucoplasia/eritroplasia.
- Adenopatía cervical palpable (ganglio duro, fijo, indoloro).

Diagnóstico diferencial:

- Úlcera traumática, afta mayor, candidiasis crónica, liquen plano erosivo, tuberculosis, sífilis terciaria.
-

3.2 Cáncer de nasofaringe

Epidemiología: más frecuente en Asia; en Chile, menos común pero importante reconocerlo.

Asociado a: **virus de Epstein-Barr (VEB)**, exposición a nitrosaminas (pescados salados), predisposición genética (HLA-A2, HLA-B17).

Síntomas característicos:

- **Epistaxis recurrente unilateral.**
- **Obstrucción nasal progresiva.**
- **Hipoacusia conductiva unilateral** (por obstrucción tubárica).
- **Adenopatía cervical masiva** (primer signo en 70%).
- **Diplopía, cefalea, neuralgia trigeminal** por invasión de base de cráneo.

Diagnóstico diferencial:

- Adenoiditis crónica, sinusitis, linfoma nasofaríngeo, poliposis nasal.
-

3.3 Cáncer de laringe

Sitios principales:

- **Glottis** (más frecuente, 60–70%).
- **Supraglottis** (epiglotis, bandas ventriculares).
- **Subglottis** (raro, peor pronóstico).

Síntoma cardinal:

- **Disfonía persistente >3 semanas** (EUNACOM clásico).

Otros:

- Odinofagia, disfagia, tos seca, sensación de cuerpo extraño, hemoptisis leve, disnea progresiva.

Signos de alarma:

- Disfonía en fumador o bebedor crónico.
- Masa cervical dura (metástasis ganglionar).
- Estridor inspiratorio (obstrucción laringotraqueal).

Diagnóstico diferencial: laringitis crónica, reflujo laringofaríngeo, nódulos o pólipos vocales, parálisis de cuerda vocal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Examen

Utilidad

Laringoscopia indirecta o nasofibroscofia flexible	Evaluación inicial de mucosa oral, orofaringe, laringe y nasofaringe.
Biopsia dirigida	Confirma diagnóstico histológico.
TC / RM de cabeza y cuello	Evaluar extensión local, invasión ósea o de partes blandas.
TAC de tórax	Descartar metástasis pulmonar.
PET-CT (si disponible)	Estadificación metabólica completa.
Punción aspirativa con aguja fina (PAAF)	Adenopatía cervical sospechosa.
Marcadores EBV (IgA anti-VCA, DNA viral)	Apoyo diagnóstico en carcinoma nasofaríngeo.

Criterios diagnósticos:

- Confirmación histológica de **carcinoma epidermoide** u otro tipo maligno.
- Estadaje **TNM** según **AJCC 8ª edición** (T: extensión local, N: ganglios, M: metástasis).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIORL / NCCN)

5.1 Enfoque general

El manejo es **multidisciplinario** (ORL-oncología-radioterapia-nutrición-fonoaudiología), con tres pilares:

1. **Cirugía** (resección local o radical).
2. **Radioterapia** (RT).
3. **Quimioterapia** (QT), principalmente con cisplatino.

5.2 Cáncer de cavidad oral

- **Estadios tempranos (I–II):** cirugía curativa (resección amplia con margen ≥ 1 cm $\pm$ vaciamiento cervical selectivo).
- **Estadios avanzados (III–IV):** cirugía + radioterapia postoperatoria o quimiorradioterapia concomitante si inoperable.
- **Rehabilitación funcional:** reconstrucción microquirúrgica, rehabilitación oral y fonoaudiológica.

5.3 Cáncer de nasofaringe

- **Tratamiento estándar:** quimiorradioterapia concomitante (cisplatino + RT externa).
- **Cirugía** reservada para biopsia o control de recidiva.
- **Terapias dirigidas / inmunoterapia** (nivolumab, pembrolizumab) en casos metastásicos o recurrentes.

5.4 Cáncer de laringe

- **Glottis temprana (T1–T2):** radioterapia exclusiva o microcirugía láser transoral (conservadora de voz).
- **Supraglottis avanzada (T3–T4):** laringectomía total + RT/QT adyuvante.
- **Inoperables o metastásicos:** quimiorradioterapia paliativa o inmunoterapia.

Objetivo siempre: preservar función respiratoria, deglutoria y fonatoria, sin comprometer la curación.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones del tratamiento

- **Disfonía y afonía** (postcirugía laríngea).
- **Disfagia y aspiración** (por resección o RT).
- **Xerostomía, mucositis, fibrosis cervical** (radioterapia).
- **Hipotiroidismo postirradiación.**
- **Depresión / aislamiento social** (impacto comunicativo).

6.2 Pronóstico (sobrevida a 5 años aprox.)

Localización	Temprano	Avanzado
Cavidad oral	80–90%	30–50%
Nasofaringe (VEB positivo)	85%	50–60%
Laringe glótica	90%	50–60%
Supraglotis/subglotis	70%	30–40%

Factores pronósticos favorables: estadio temprano, VPH positivo, no fumador, márgenes negativos.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas clínicas

1. **Disfonía >3 semanas en fumador = cáncer laríngeo hasta demostrar lo contrario.**
2. **Úlcera oral que no cicatriza >2–3 semanas requiere biopsia inmediata.**

3. **Rinorrea purulenta unilateral + epistaxis + hipoacusia conductiva** → pensar en **carcinoma nasofaríngeo**.
4. **Lesiones orales rojas o blancas persistentes (eritroplasia/leucoplasia)** son **pre malignas**.
5. **VPH** explica muchos cánceres orofaríngeos en **jóvenes no fumadores**; mejor pronóstico.
6. **Biopsia bajo visión directa** es el **estándar diagnóstico**.
7. En Chile, el **GES “Cáncer oral y orofaríngeo”** cubre diagnóstico y tratamiento integral.

✗ Errores comunes

- Tratar **úlceras crónicas con antibióticos tópicos** sin biopsia.
- Atribuir disfonía prolongada a “laringitis” sin derivar a ORL.
- No palpar **ganglios cervicales** en examen oral.
- Creer que todos los cánceres ORL se operan (en nasofaringe, el manejo es médico-radioterápico).
- No derivar **a tiempo** para diagnóstico histológico.
- Omitir **evaluación dental previa a radioterapia**.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **carcinoma epidermoide** es el cáncer más frecuente de cavidad oral, laringe y nasofaringe.
2. **Factores de riesgo**: tabaco, alcohol, VPH (orofaringe), VEB (nasofaringe).
3. **Signos de alarma**: disfonía >3 semanas, úlcera oral persistente, epistaxis unilateral, masa cervical.
4. **Diagnóstico**: visualización + biopsia + TC/RM para estadificación.
5. **Tratamiento**: cirugía, radioterapia y quimioterapia según localización y estadio.

6. **VPH positivo** mejora pronóstico y respuesta a tratamiento.
7. **Derivación temprana desde APS** mejora sobrevida y preserva funciones vitales.